



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



Subtipos · reversíveis · investigação

Saúde do Idoso

Diagnóstico dos Transtornos Neurocognitivos

Diferenciar os subtipos — e não perder o que é tratável

TEMA	Diagnóstico dos TNC: subtipos, reversíveis (HPN) e investigação
AUTOR	Prof. Dr. Igor Moraes — CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254; Clínica Médica; Cardiologia)
DISCIPLINA	Saúde do Idoso — 9º período
INSTITUIÇÃO	FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CARGA HORÁRIA	35 minutos (panorâmica)
DATA / VERSÃO	2026 · v1.0

Idoso que esquece E começou a andar “travado” e a perder urina — só Alzheimer?



Foto ilustrativa • CC BY-SA

Sr. A., 76 anos

Declínio cognitivo há 1 ano.

Marcha lenta, “grudada no chão”.

Incontinência urinária recente.

Três perguntas, nesta ordem:



1. É transtorno neurocognitivo? (síndrome)



2. É REVERSÍVEL? (não perca o tratável!)



3. Qual o subtipo? (diferencial)

A tríade do Sr. A. (cognição + marcha + incontinência) deveria acender uma luz...

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final, você diferencia os subtipos e não perde o tratável



Aplicar

1

o eixo DSM-5: TNC maior × leve (papel da funcionalidade).



Estruturar

2

o fluxo: síndrome → excluir reversível → imagem → etiologia.



Reconhecer

3

causas reversíveis — com destaque para a HPN.



Diferenciar

4

Alzheimer, vascular, FTD, Lewy/Parkinson e mista.



Selecionar

5

laboratório, neuroimagem e biomarcadores (ATN).

Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz.

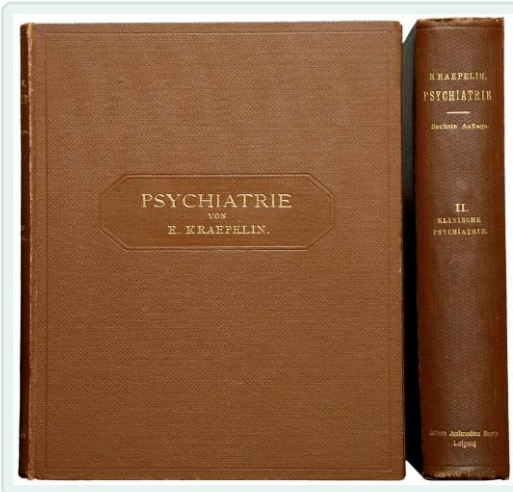
Da síndrome ao subtipo — passando pelo que é tratável



Excluir o reversível vem ANTES de rotular a etiologia degenerativa.

1 • LINHA HISTÓRICA (FONTES PRIMÁRIAS)

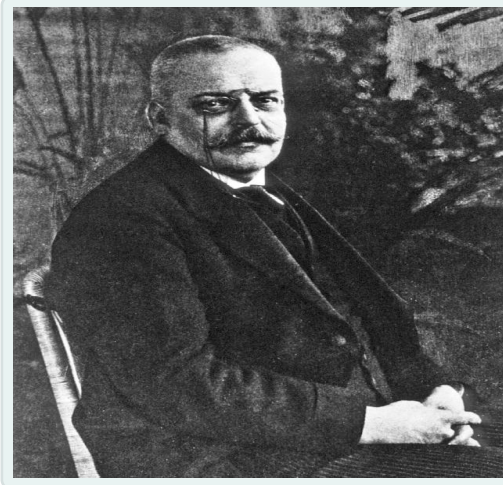
Cada demência tem um nome e uma origem — fontes reais



Psychiatrie · PD/CC

Kraepelin (1899)

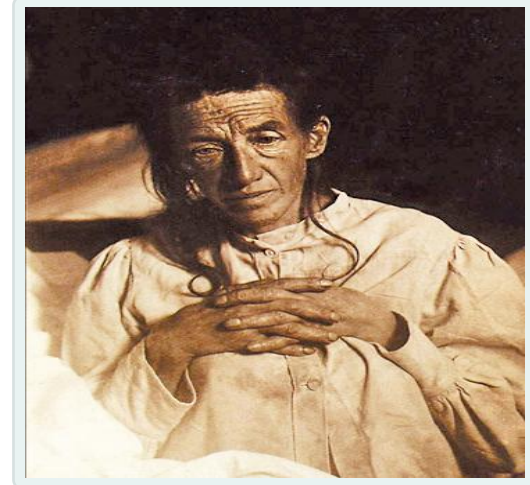
Sistematiza a nosologia — “Psychiatrie”



A. Alzheimer · domínio público

Alzheimer (1906)

Descreve a doença a partir de Auguste D.



Auguste D. (1902) · domínio público

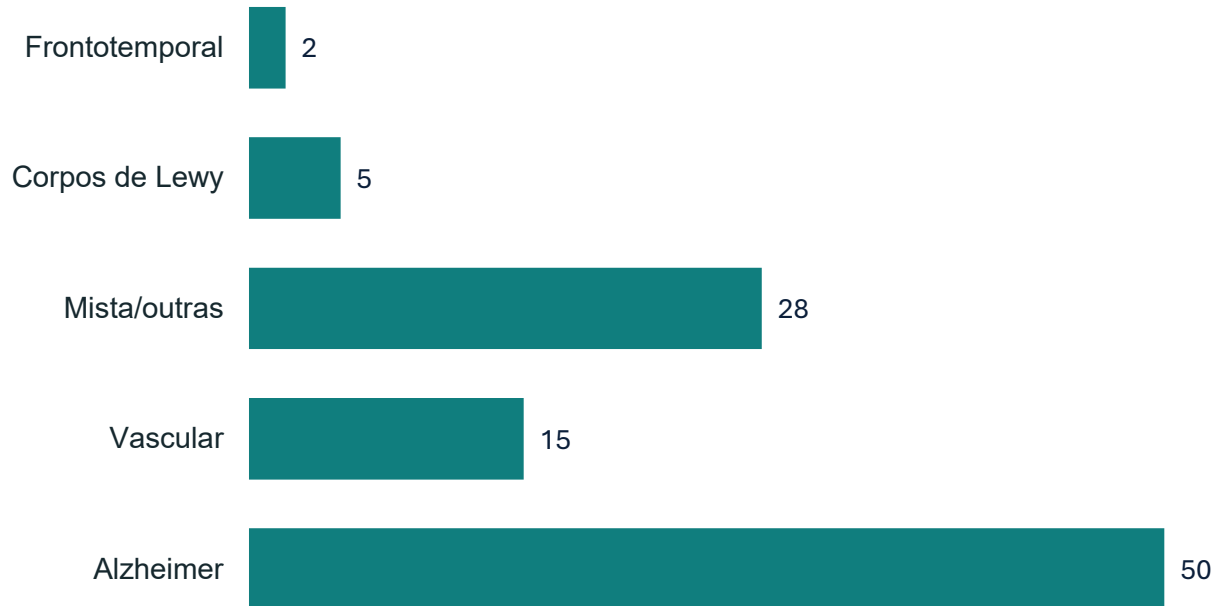
Auguste Deter

A 1ª paciente: a “realidade” do conceito

Adiante, cada subtipo aparece com quem o descreveu: Pick, Binswanger, Lewy, Hakim.

Alzheimer lidera, mas no muito idoso a demência mista é a regra

Proporção dos subtipos no idoso (aprox.)



Proporções aproximadas (literatura internacional); variam por casuística e idade de início.



Foto ilustrativa - CC BY-SA

Implicação: no idoso, a sobreposição (ex.: Alzheimer + vascular) é comum — pense em mista e não force um rótulo único.

DSM-5: transtorno neurocognitivo MAIOR × LEVE — a funcionalidade decide



TNC LEVE

- Declínio modesto em ≥1 domínio
- Documentado (preocupação + teste)
- NÃO compromete a independência
- Equivale ao conceito de CCL



TNC MAIOR

- Declínio substancial em ≥1 domínio
- Documentado por relato + testes
- COMPROMETE a independência (AVD)
- Equivale ao conceito de demência

Depois do eixo (leve/maior) vem o ESPECIFICADOR ETIOLÓGICO: devido a Alzheimer, vascular, FTD, Lewy/Parkinson, HPN, etc.

4 · FLUXO DIAGNÓSTICO

Quatro passos: síndrome → excluir reversível → imagem → etiologia



1. Síndrome

Há TNC? leve ou maior? (clínica + testes + informante)



2. Excluir reversível

Labs + imagem para o tratável (inclui HPN)



3. Neuroimagem

TC/RM: atrofia, vascular, HPN, lesões estruturais



4. Etiologia

Padrão clínico + imagem (± biomarcadores) → subtipo

Regra de ouro: todo paciente com TNC merece, ao menos uma vez, exames básicos + neuroimagem estrutural para não perder causa tratável.

Antes de “é demência”, exclua as causas tratáveis



B12 / folato

dosar; repor



Tireoide (TSH)

hipotireoidismo



Depressão

pseudodemência



Fármacos

anticolinérgicos, sedativos



Metabólico/infeccioso

Na, Ca, hepático; sífilis/HIV



Hematoma subdural

trauma; anticoagulação



Hidrocefalia de PN

tríade de Hakim (próx. slide)

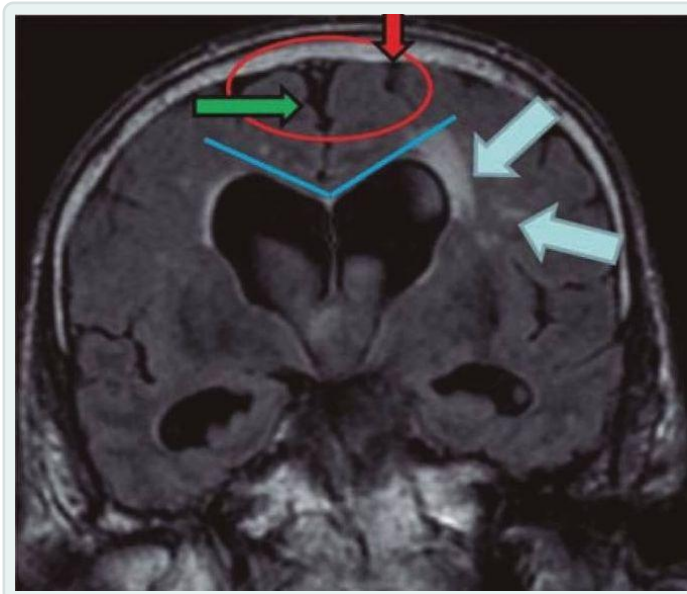


Álcool / nutricional

tiamina (B1)

Reversíveis são minoria dos casos — mas é inaceitável perder um. A HPN é a estrela: tem o nosso próximo slide.

Hidrocefalia de pressão normal: “molhado, trôpego e esquecido”



RM: ventriculomegalia/DESH • CC BY-SA



Marcha

apraxia/magnética — costuma ser o 1º e o que mais melhora



Incontinência

urinária (urgência → incontinência)



Cognição

disexecutiva/lentificação (subcortical)



Imagem & manejo

RM: ventrículos↑ desproporcional à atrofia; Evans >0,3; DESH; ângulo caloso estreito

Tap test (punção lombar de alívio) prediz resposta

Tratamento: derivação ventrículo-peritoneal (DVP)

Por que importa: é uma das poucas demências potencialmente reversíveis. Pense em HPN em todo idoso com declínio + alteração de marcha + incontinência. Selo: Colômbia homenageia Salomón Hakim (PD).

Cada subtipo tem uma “primeira queixa” característica

Subtipo	1ª manifestação	Pista marcante
Alzheimer	Memória episódica	Amnésia que não melhora c/ pistas
Vascular	Executivo / lentificação	Curso em degraus; fatores vasculares
Frontotemporal	Comportamento OU linguagem	Jovem (<65); desinibição/apatia
Corpos de Lewy	Flutuação + alucinação visual	Parkinsonismo; sono REM; ↑sensib. neuroléptico

Nos próximos slides, cada subtipo com o rosto de quem o descreveu — e seu padrão clínico e de imagem.

Doença de Alzheimer: o protótipo amnésico



Alois Alzheimer (1906) - domínio público



1ª manifestação

Memória episódica recente (esquece e não recupera com pistas)



Padrão / curso

Início insidioso, progressão lenta; depois linguagem, visuoespacial



Neuroimagem

RM: atrofia hipocampal/temporal medial; ATN: amiloide + tau +



Pista / red flag

Anosognosia; preservação da marcha no início (≠ HPN)

Fonte: NIA-AA (McKhann 2011); ATN (Jack 2018); ABN 2022.

Demência vascular: degraus, disexecução e fatores de risco



Otto Binswanger

Otto Binswanger · domínio público



1ª manifestação

Função executiva e velocidade de processamento (subcortical)



Padrão / curso

Curso em DEGRAUS ou relação temporal com AVC; flutua



Neuroimagem

RM: infartos, lacunas, leucoaraiose (substância branca)



Pista / red flag

HAS/DM/FA; sinais focais, marcha alterada precoce

Fonte: VASCOG / NINDS-AIREN; Gorelick (AHA/ASA) 2011; ABN 2022.

Frontotemporal: muda o comportamento ou a linguagem, não a memória



Arnold Pick (doença de Pick) • domínio público



1ª manifestação

Comportamento (desinibição/apatia) OU linguagem (APP)



Padrão / curso

Início mais jovem (<65); memória relativamente poupada no início



Neuroimagem

RM: atrofia frontal e/ou temporal anterior (assimétrica)

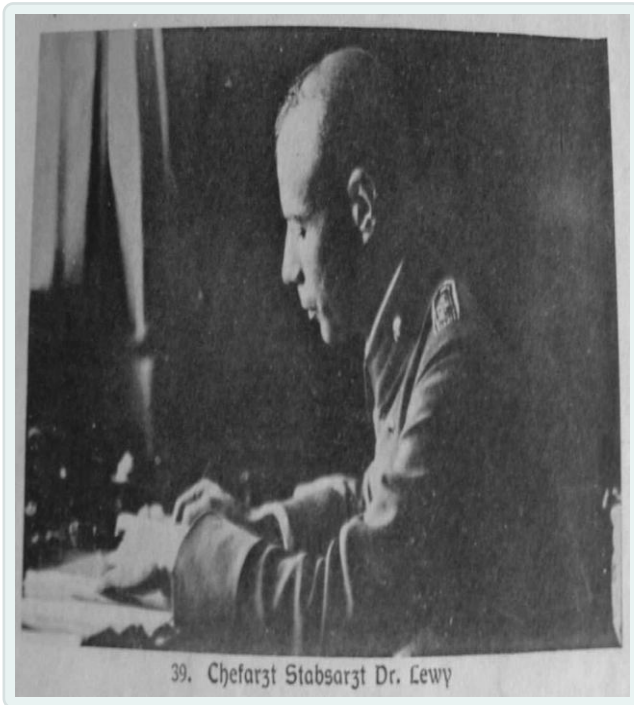


Pista / red flag

Mudança de personalidade/conducta; hiperoralidade; perda de empatia

Fonte: Rascovsky 2011 (bvFTD); Gorno-Tempini 2011 (APP); ABN.

Corpos de Lewy: flutuação, alucinações visuais e parkinsonismo



Friedrich H. Lewy · domínio público



1ª manifestação

Flutuação cognitiva + alucinações visuais bem formadas



Padrão / curso

Parkinsonismo; atenção/visuoespacial > memória no início



Neuroimagem

RM pouco específica; suporte: DAT-SPIrit, cintilografia (avançado)



Pista / red flag

HIPERSENSIBILIDADE a neurolépticos; transtorno comportamental do sono REM

Fonte: McKeith 2017 (consenso DLB); MDS (Emre 2007, PDD); ABN.

No idoso, pense mista — e fique atento aos sinais atípicos



Demência mista

- Coexistência de patologias (ex.: Alzheimer + vascular)
- Muito comum no muito idoso
- Quadro “híbrido”: amnésico + executivo/vascular
- Conduta: tratar o que é tratável em cada eixo



Red flags de atípico (investigue+)

- Início < 65 anos ou evolução rápida (< 6–12 m)
- Sinais focais, mioclonias, convulsões
- Marcha/quedas precoces; parkinsonismo atípico
- Predomínio psiquiátrico/comportamental

Atípico = encaminhar ao especialista e investigar (incl. priônica, autoimune, etc.).

Sr. A.: declínio + marcha magnética + incontinência. Qual a prioridade?

Pistas

- Tríade cognição + marcha + urina
- Marcha “magnética” precoce
- Sem fatores vasculares marcantes
- Cognição disexecutiva, não amnésica pura

Conduta mais correta

A

Diagnosticar Alzheimer e iniciar anticolinesterásico

B

Neuroimagem pensando em HPN (ventriculomegalia/DESH) → tap test

C

Iniciar antipsicótico para “agitação”

Resposta: B — a tríade pede investigação de HPN (reversível) antes de rotular degenerativa.

Exames básicos: baratos, e podem mudar o diagnóstico



TSH

hipotireoidismo



B12 (± folato)

deficiência



Hemograma, Na, Ca

metabólico



Função renal/hepática

encefalopatia



Glicemia / HbA1c

metabólico



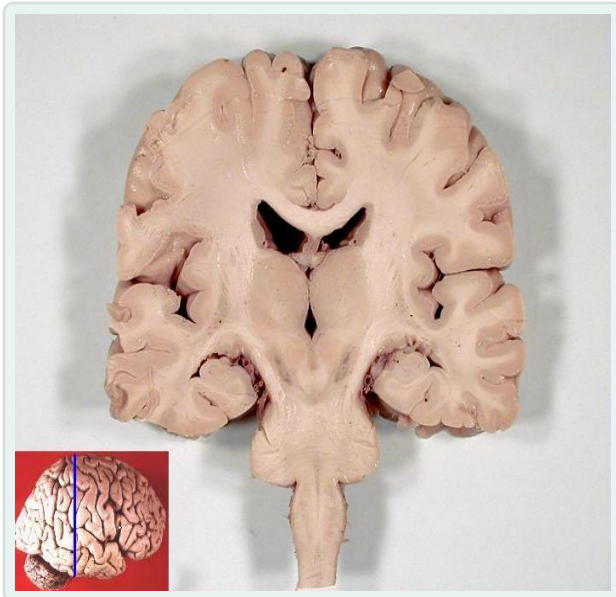
Sífilis / HIV

se fatores de risco



Painel mínimo recomendado a todo TNC. Direcione exames adicionais (autoimune, líquido, EEG) pela suspeita clínica e pelas red flags.

Neuroimagem estrutural (TC/RM): exclui tratável e apoia o subtipo



Encéfalo (corte) · CC BY 2.5



Exclui o tratável

tumor, hematoma subdural, HPN (ventriculomegalia/DESH)



Doença vascular

infartos, lacunas, leucoaraiose → vascular/mista



Padrão de atrofia

hipocampo/temporal medial (Alzheimer); frontotemporal (FTD)



Quando RM > TC

início precoce, foco, dúvida de subtipo, atípicos

Biomarcadores e o modelo ATN: úteis em casos selecionados



A — Amiloide

PET amiloide; A β 42 (ou A β 42/40) no líquido



T — Tau

p-tau no líquido; PET tau



N — Neurodegeneração

atrofia (RM), FDG-PET, tau total



Quando usar: diagnóstico incerto, início precoce, pesquisa/uso de terapias específicas. NÃO são rastreio populacional. O diagnóstico segue clínico; biomarcadores aumentam a certeza etiológica (ex.: Alzheimer A+T+).

Fonte: estrutura ATN (Jack et al. 2018); NIA-AA.

Fechar o diagnóstico é começar o cuidado — não o fim



Comunicar & planejar

- Comunicar com empatia; incluir família/cuidador
- Diretivas antecipadas enquanto há capacidade
- Segurança: direção, finanças, medicações



Tratar & integrar

- Tratar o reversível (HPN→DVP; repor déficits)
- Não-farmacológico 1º; antedemenciais conforme tipo
- Integrar à AGA: funcionalidade, humor, fármacos, rede

Atenção: nos corpos de Lewy, evitar/ter extrema cautela com neurolépticos típicos (risco grave).

O erro nº 1: chamar tudo de Alzheimer e perder o tratável



A armadilha

Rotular todo declínio como Alzheimer

→ perde HPN (operável), vascular (prevenível), Lewy (muda fármaco), reversíveis.



Como evitar

- Aplique a régua: é TNC? é reversível? qual subtipo?
- Imagem + labs ao menos uma vez
- Marcha + incontinência + cognição = pense HPN



Curiosidade: Salomón Hakim, neurocirurgião colombiano, descreveu a HPN e criou a válvula de derivação — feito tão celebrado que rendeu até um selo postal (que usamos no slide da HPN).

A régua do diagnóstico dos TNC

1) É TNC? (leve×maior = funcionalidade) **2) É REVERSÍVEL?** (HPN, B12, tireoide...) **3) QUAL SUBTIPO?**



Excluir o tratável 1º

Imagem + labs em todo TNC. HPN = cognição + marcha + incontinência → derivação.



Subtipo pela 1ª queixa

AD: memória · Vascular: executivo/degraus · FTD: conduta/jovem · Lewy: flutuação/alucinação/parkinson.



No idoso, pense mista

Sobreposição é a regra; cuidado com neuroléptico no Lewy.

Teste rápido: Q1 a Q3

Q1

Idoso com declínio + marcha magnética + incontinência urinária. Pensar primeiro em?

A) Alzheimer B) HPN C) Depressão D) FTD

Q2

Declínio cognitivo + alucinações visuais + flutuação + parkinsonismo. Subtipo?

A) Vascular B) Alzheimer C) Corpos de Lewy D) HPN

Q3

O que define TNC MAIOR (vs. leve) no DSM-5?

A) Escore do MEEM B) Idade C) Perda de independência nas AVD D) Atrofia na RM

Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.

Mais três e os comentários

Q4. Curso em degraus + fatores de risco vascular + lacunas na RM. Subtipo?

Q5. Mudança de comportamento/desinibição aos 60a, memória poupada. Subtipo?

Q6. 1º exame para excluir causa tratável em todo TNC?

Gabarito comentado

Q1 → B — Tríade de Hakim = HPN, reversível; investigue antes de rotular.

Q2 → C — Flutuação + alucinação visual + parkinsonismo = Lewy.

Q3 → C — Maior = perde independência nas AVD; leve = preserva.

Q4 → Vascular — Degraus + fatores + lacunas/leucoaraiose.

Q5 → FTD — Conduta/desinibição em <65 com memória poupada.

Q6 — Labs (TSH, B12, Na...) + TC/RM ao menos uma vez.

Recapitule agora — e revise nos próximos dias

Em 30 segundos, recupere de memória:

- A régua: TNC? reversível? subtipo?
- A tríade da HPN e seu tratamento
- A 1ª queixa de cada subtipo
- Painel mínimo de investigação



3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Quando suspeitar de HPN e como confirmar?
2. Como diferenciar Alzheimer de demência vascular?
3. Que achados de imagem mudam a conduta?

REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

Referências

1. American Psychiatric Association. DSM-5 — Transtornos Neurocognitivos. 2013.
2. Academia Brasileira de Neurologia (Dep. Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento). Recomendações 2022: diagnóstico de Alzheimer; comprometimento cognitivo vascular; diagnóstico sindrômico. Dement Neuropsychol/Arq Neuropsiquiatr.
3. McKhann GM, et al. NIA-AA — diagnóstico de doença de Alzheimer. Alzheimers Dement. 2011. · Jack CR, et al. ATN framework. 2018.
4. Gorelick PB, et al. Vascular contributions to cognitive impairment (AHA/ASA). Stroke. 2011. · Critérios VASCOG/NINDS-AIREN.
5. Rascofsky K, et al. Critérios para variante comportamental da DFT (bvFTD). Brain. 2011. · Gorno-Tempini ML, et al. APP. Neurology. 2011.
6. McKeith IG, et al. Consenso diagnóstico para demência com corpos de Lewy (4ª ed.). Neurology. 2017. · Emre M, et al. PDD (MDS). 2007.
7. Hakim S, Adams RD. Hidrocefalia de pressão normal (tríade). J Neurol Sci. 1965. · Critérios de HPN idiopática (diretrizes).
8. Folstein MF, et al. MMSE. 1975. · Brucki SMD, et al. MEEM no Brasil. Arq Neuropsiquiatr. 2003.
9. ELSI-Brasil — prevalência de demência. · Proporções de subtipos: literatura internacional.
10. Petersen RC. Mild Cognitive Impairment. N Engl J Med. 2011.

Cortes e proporções variam por população/casuística; conferir critérios e validações vigentes.

CRÉDITOS

Créditos de imagens e nota de marca

Imagens documentais (domínio público / Wikimedia Commons):

- Kraepelin (Psychiatrie), Alois Alzheimer, Auguste Deter — domínio público
- Arnold Pick (DFT), Otto Binswanger (vascular), Friedrich Lewy (corpos de Lewy) — domínio público
- Selo “Síndrome y Válvula – S. Hakim” (HPN) — domínio público
- RM de HPN (ventriculomegalia/DESH) — CC BY-SA · Encéfalo (corte), J. A. Beal — CC BY 2.5

Fotos ilustrativas (Wikimedia, CC BY-SA): idosos no Brasil — Adam Jones. **Ícones:** Font Awesome. **Diagramas:** originais.



Marca institucional: logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG.

Obrigado!

Diante do declínio: **é TNC? é reversível? qual subtipo?**

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG

